



ferfoli®

hierro 90 mg + ácido fólico 1 mg



Un embarazo
saludable
ofrece s😊nrisas
felices



Bial

Keeping life
in mind.

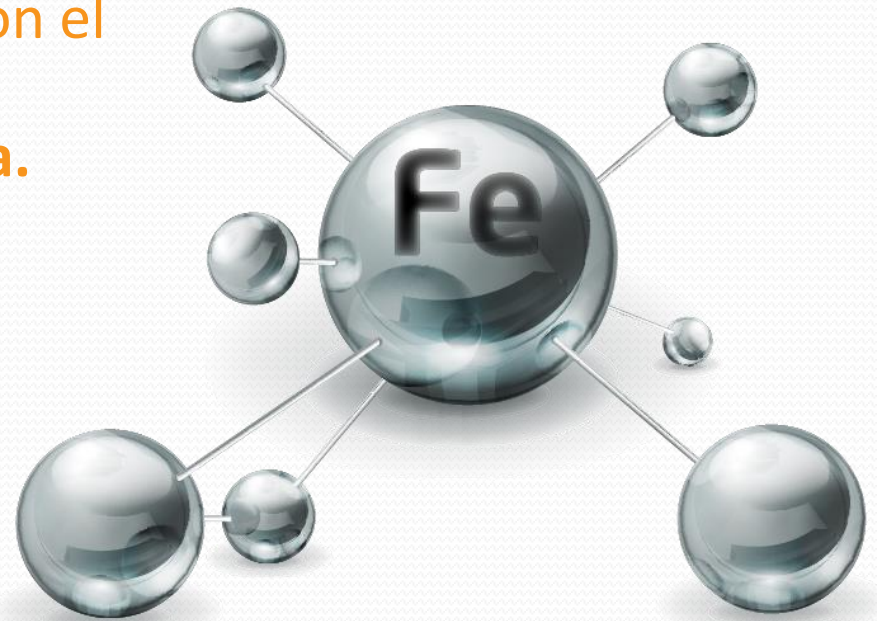
Evento
Local y fecha
Nombre del presentador

¿POR QUÉ NECESITAMOS HIERRO EN NUESTRO CUERPO?



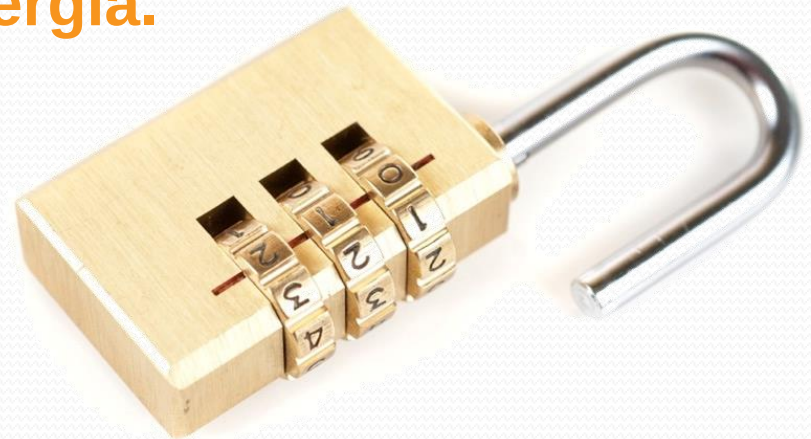
QUÍMICA DEL HIERRO

- **El hierro es un metal, un elemento químico con el símbolo Fe.**
- **Juega un papel importante en la biología, formando complejos con el oxígeno molecular en la hemoglobina y en la mioglobina.**
- **Se utiliza en el sitio activo de muchas enzimas redox importantes.**



LAS 3 FUNCIONES PRINCIPALES DEL HIERRO

- **Transportar oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo.**
- **Mantener un sistema inmunológico saludable.**
(el cuerpo se protege de los antígenos, que incluyen virus, bacterias y sustancias extrañas que enferman)
- **Ayudar a la producción de energía.**
(El hierro es un constituyente de varias enzimas incluyendo: catalasa de hierro, peroxidasa y enzimas del citocromo)



¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA DEFICIENCIA DE HIERRO?



¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA DEFICIENCIA DE HIERRO?

Desnutrición

Malabsorción

Aumento de
las
necesidades

Pérdida de
sangre



¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA DEFICIENCIA DE HIERRO?

- **Pérdida de sangre**
 - Menorragia
 - Hemorragia intestinal crónica
 - Una úlcera sangrante, colon, pólipos
 - Uso regular de AINEs
 - Lesión severa o cirugía
- **Desnutrición**
- **Malabsorción**
 - Trastornos intestinales
 - Enfermedad de Crohn
 - Enfermedad celíaca
 - Uso regular de bloqueadores de ácido estomacal
 - Ciertos alimentos como leche, té, café.
- **Aumento de las necesidades** de hierro en la edad juvenil, embarazo, lactancia



REQUERIMIENTOS TOTALES DE HIERRO DURANTE EL EMBARAZO TRADUCIDOS A REQUERIMIENTOS DIARIOS

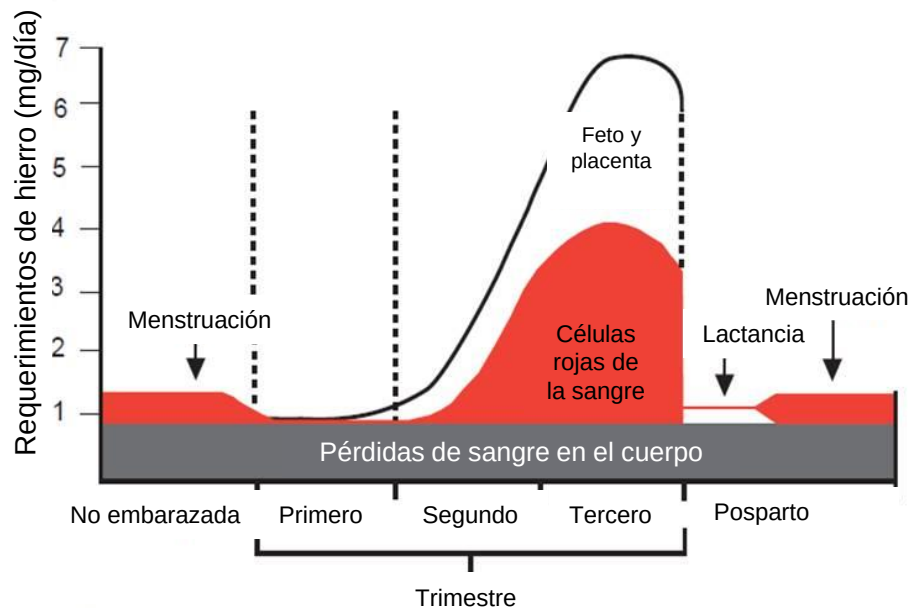


FIGURE 2. Estimated daily iron requirements during pregnancy in a 55-kg woman. Modified from Bothwell et al (7) with permission.

LOS REQUERIMIENTOS DE NUTRIENTES AUMENTAN DURANTE EL EMBARAZO PARA APOYAR EL CRECIMIENTO FETAL Y LA SALUD MATERNA.^{1,2,3}

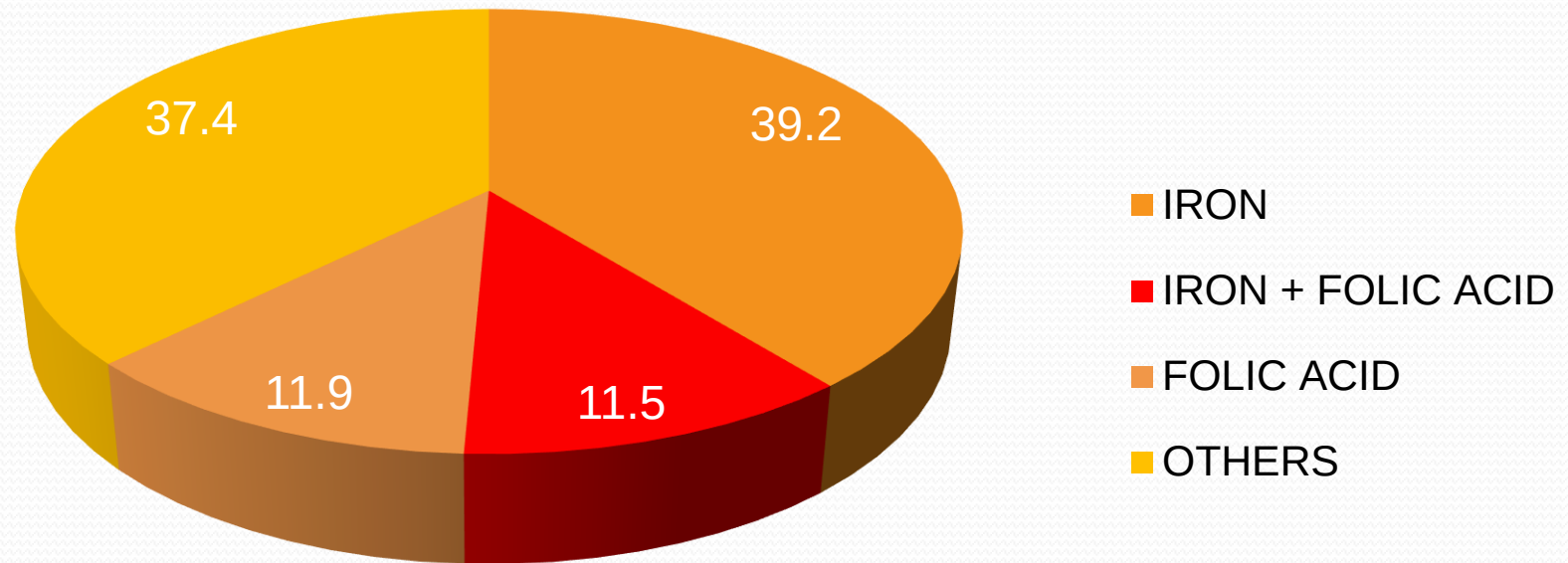
- **Requerimientos basales:** representa 0,8 mg/día, lo mismo que las pérdidas diarias.
- **Requerimientos durante el embarazo:** aumentar de 0,8mg a unos 10mg durante las últimas 6 semanas.
- **Requerimientos de mujeres lactantes:** pérdida diaria de hierro en la leche (0,3mg) + pérdidas diarias normales (0,8mg) = 1,1mg/día.

1) National Institutes of Health 2007

2) Joint FAO/WHO Expert Consultation on Human Vitamin and Mineral Requirements. WHO 2004

3) Bothwell TH. Am J Clin Nutr 2000;72(suppl):257S-64S

CAUSAS DE LA ANEMIA DURANTE EL EMBARAZO (%)¹



En los países en desarrollo, el 25-30% de las mujeres no tienen reservas de hierro.²

Combinado con otros micronutrientes, **el ácido fólico debe ser administrado siempre junto con hierro durante el embarazo.**²

CÓMO DIAGNOSTICAR LA ANEMIA POR CARENCIA DE HIERRO

ferfoli[®]
hierro 90 mg + ácido fólico 1 mg



DIAGNÓSTICO DE LA ANEMIA DURANTE EL EMBARAZO

Parámetros para evaluar el estado nutricional de hierro⁸

PARÁMETROS DE LABORATORIO	NORMAL	DEPLECIÓN DE LAS RESERVAS	ERITROPOYESIS CON DÉFICIT DE HIERRO (FERROPENIA)	ANEMIA FERROPÉNICA
FERRITINA SÉRICA RESERVAS DE HIERRO				
TRANSFERRINA TRANSPORTE DE HIERRO				
HEMOGLOBINA HIERRO ERITROCITARIO				

Adaptado de 8.

Normal Ferritin Levels in Male: 12-300 ng/mL and in Female: 12-150 ng/mL. The lower the ferritin level, **even within the "normal" range**, the more likely it is that the patient does not have enough iron.

The sequence of events (left to right) that occur with gradual depletion of body stores of iron. Serum ferritin and stainable iron in tissue stores are the most sensitive laboratory indicators of mild iron deficiency and are particularly useful in differentiating iron deficiency from the anaemia of chronic disorders. The percentage saturation of transferrin with iron and free erythrocyte protoporphyrin values do not become abnormal until tissue stores are depleted of iron. Subsequently, a decrease in the hemoglobin concentration occurs because iron is unavailable for heme synthesis. Red blood cell indices do not become abnormal for several months after tissue stores are depleted of iron.

EL PAPEL ESENCIAL DEL ÁCIDO FÓLICO Y EL HIERRO DURANTE EL EMBARAZO

ferfoli[®]
hierro 90 mg + ácido fólico 1 mg

- **ÁCIDO FÓLICO**

- Es un nutriente esencial que desempeña un papel importante durante las fases de **rápida división celular** y **crecimiento**.

- **HIERRO**

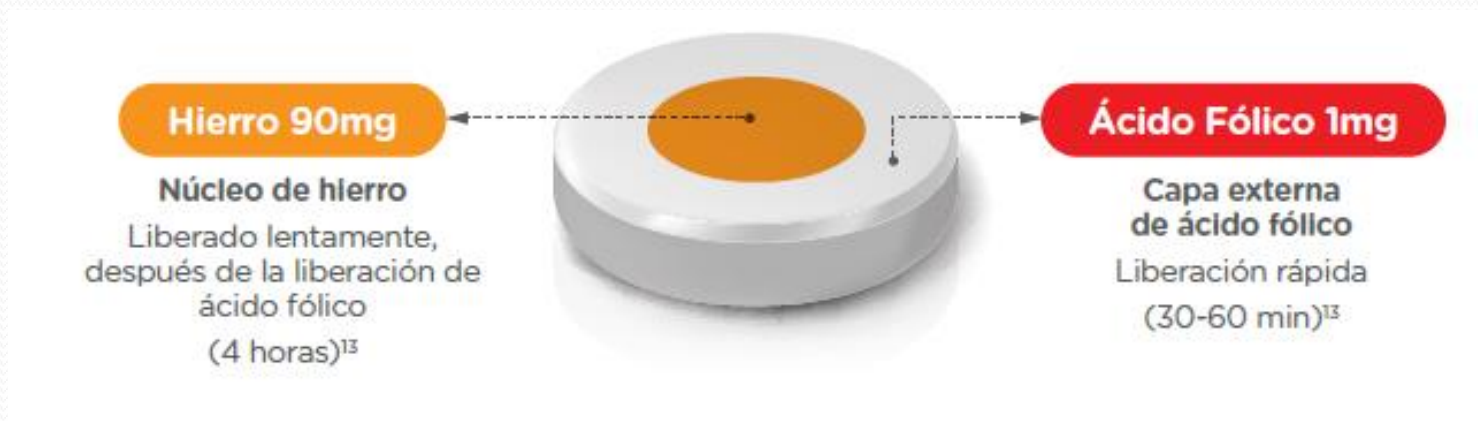
- El hierro es un nutriente esencial para el **transporte de oxígeno** en el organismo, a través de la hemoglobina, y para el **crecimiento y la supervivencia celular**.
- Durante el embarazo, el **ácido fólico debe ser administrado siempre junto con hierro**, ya que durante este período existe una mayor necesidad de ambos nutrientes. Además, los déficits de ácido fólico y de hierro suelen ocurrir simultáneamente, y son particularmente comunes en el **embarazo**, la **lactancia** y el **posparto**.

La administración concomitante de ácido fólico y hierro facilita la respuesta fisiológica al tratamiento del déficit de hierro durante el embarazo en comparación con hierro solo.

FÓRMULA GALÉNICA ÚNICA

ferfoli[®]
hierro 90 mg + ácido fólico 1 mg

Fórmula galénica de liberación prolongada: MEJOR TOLERABILIDAD



FÓRMULA GALÉNICA – MEJOR TOLERABILIDAD

Las formulaciones de hierro de liberación controlada causan menos efectos secundarios, como náuseas y epigastralgias, que las formulaciones Convencionales de sulfato ferroso.

La fórmula galénica de Ferfoli es una formulación de liberación controlada, que libera Ácido Fólico en 30 minutos y 60 mg de Hierro en las primeras 4 horas.

Bial

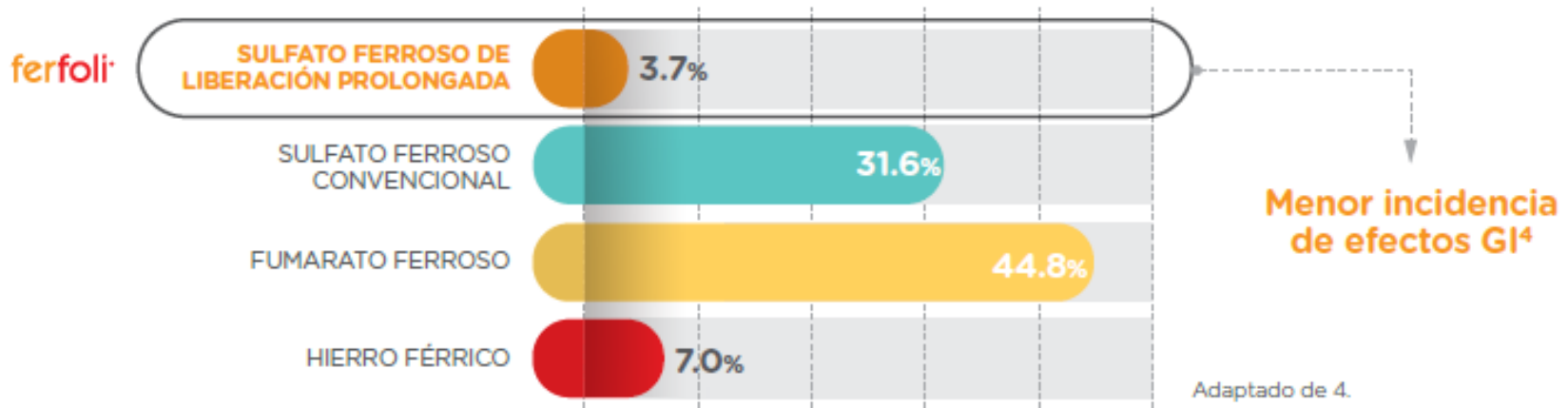
FÓRMULA GALÉNICA ÚNICA

ferfoli[®]
hierro 90 mg + ácido fólico 1 mg

FÓRMULA GALÉNICA – MEJOR TOLERABILIDAD

Incidencia de efectos gastrointestinales (GI)

(106 estudios publicados hasta 2008, que incluyen 10 515 individuos)



ASOCIADO CON ÁCIDO FÓLICO ¿O SOLO?

ferfoli[®]
hierro 90 mg + ácido fólico 1 mg

LAS DIRECTRICES DE LA OMS DEFIENDEN:

La combinación (hierro+ácido fólico) es importante debido al mayor requerimiento de ácido fólico de las mujeres embarazadas y al hecho de que **ambas deficiencias son comunes en el embarazo.**¹



© WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001

Bial

- Cumple las recomendaciones de la OMS en **cantidad y tipo de hierro** por ser **combinado con ácido fólico**.
- **Libera 59,4 mg de hierro elemental** en las primeras 4 horas.
- **Buena tolerabilidad** debido a su forma galénica única, que consiste en un núcleo de sulfato ferroso y una capa externa de ácido fólico.
- Sulfato ferroso - **1.ª línea de tratamiento** de la anemia por déficit de hierro debido a su tolerabilidad, eficacia y bajo coste.
- **Práctico:** 1 toma diaria.

POSOLOGÍA Y PRESENTACIÓN

ferfoli®
hierro 90 mg + ácido fólico 1 mg

INDICADO EN LA
PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LOS
ESTADOS DE CARENCIA
DE HIERRO Y ÁCIDO
FÓLICO EN EL EMBARAZO,
LA LACTANCIA Y
PUERPERIO.¹³

Posología
**1 COMPRIMIDO
AL DÍA¹³**

Presentación
60 COMPRIMIDOS

Durante el
embarazo y la
lactancia.¹³



Bial

1. Greenberg, James A., et al. "Folic acid supplementation and pregnancy: more than just neural tube defect prevention." *Reviews in Obstetrics and Gynecology* 4.2 (2011): 52. 2. Wilson, R. Douglas, et al. "Pre-conceptional vitamin/folic acid supplementation 2007: the use of folic acid in combination with a multivitamin supplement for the prevention of neural tube defects and other congenital anomalies." *Journal of obstetrics and gynaecology Canada* 29.12 (2007): 1003-1013. 3. Mirza, Fadi G., et al. "Impact and management of iron deficiency and iron deficiency anemia in women's health." *Expert review of hematology* 11.9 (2018): 727-736. 4. Santiago, Palacios. "Ferrous versus ferric oral iron formulations for the treatment of iron deficiency: a clinical overview." *The Scientific World Journal* 2012 (2012). 5. World Health Organization. "Iron deficiency anemia. assessment, prevention, and control." *A guide for programme managers* (2001): 47-62. 6. Patricio, José PH, Cristina Santos, and Rui Cerdeira. "In vitro dissolution profile of two commercially available iron preparations." *Drugs in R&D* 12.1 (2012): 35-40. 7. Fonseca, C., et al. "Prevalence of anaemia and iron deficiency in Portugal: the EMPIRE study." *Internal medicine journal* 46.4 (2016): 470-478. 8. World Health Organization. "Nutritional anaemias: tools for effective prevention and control." (2017). 9. World Health Organization. WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. World Health Organization, 2016. 10. Bothwell, Thomas H. "Iron requirements in pregnancy and strategies to meet them." *The American journal of clinical nutrition* 72.1 (2000): 257S-264S. 11. World Health Organization. "Guideline: Iron supplementation in postpartum women." (2016). 12. McDiarmid, Todd, and E. Diane Johnson. "Are any oral iron formulations better tolerated than ferrous sulfate?." *Clinical Inquiries*, 2002 (MU) (2002). 13. Resumen de las Características del Medicamento Ferfoli®.

OMS Organización Mundial de la Salud

FERFOLI comprimido constituido por un núcleo conteniendo 90 mg de hierro (bajo la forma de sulfato ferroso) y 1 mg de ácido fólico.

Indicaciones terapéuticas: Las principales indicaciones terapéuticas de FERFOLI son la profilaxis y tratamiento de los estados de déficit de hierro y ácido fólico, en el embarazo, puerperio y lactancia prolongada. **Posología y forma de administración:** Excepto otra indicación médica, ingerir 1 comprimido de FERFOLI al día, entero, con agua o zumo de fruta (evitar la leche), preferentemente con el estómago vacío. En caso de intolerancia gástrica se recomienda la ingesta después de las comidas (almuerzo o cena). La duración del tratamiento será establecida por el médico.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad conocida al producto. Sobrecarga de hierro en el organismo (hemocromatosis, hemólisis crónica o pacientes sometidos a transfusiones sanguíneas repetidas). Terapia parental concomitante con hierro. Anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12.

Advertencias y precauciones especiales de empleo: Excepcionalmente, puede aparecer hipersensibilidad al ácido fólico. Esta asociación no debe ser utilizada para la profilaxis de las malformaciones del tubo neural en mujeres que planean quedarse embarazadas. Tampoco debe ser utilizada esta asociación como tratamiento de las anemias megaloblásticas: en el caso de deficiencia de ácido fólico las dosis reducidas de este micronutriente en la asociación no son suficientes para el tratamiento; en caso de anemia perniciosa, el ácido fólico presente en FERFOLI puede enmascarar el diagnóstico al mejorar las manifestaciones hematológicas mientras que se agravan las manifestaciones neurológicas de déficit de Vitamina B12. Utilizar con precaución en caso de afecciones agudas del tracto digestivo. La eventual aparición de heces de color oscuro es normal. Esta especialidad contiene lactosa. **Presentación:** FERFOLI, envase con 60 comprimidos. **Medicamento sujeto a receta médica. Titular de la Autorización de Comercialización:** BIAL-Portela & C^ª, S.A. • À Av. da Siderurgia Nacional - 4745-457 S. Mamede do Coronado • Portugal.

Información complementaria bajo pedido. DIDSAM 170314

GRACIAS!

Si tiene alguna pregunta, por favor
diríjala a nuestro equipo médico:
denise.marques@bial.com



Bial

Keeping life
in mind.